RAPPORT FORMEL D'ÉVALUATION DE SÉCURITÉ CLINIQUE (GVP MODULE VII/IX)

RAPPORT D'ÉVALUATION BÉNÉFICE / RISQUE EVAL-2024-016 - CARDIOLUX

Réf Évaluation :	EVAL-2024-016	**Produit Rattaché :**	Cardiolux
Indication Revue :	Traitement de l'hypertension a...	**Exposition Estimée :**	1 250 000 unités
Lead Évaluateur :	Dr. Karim Belkacem (MD)	**Validation QPPV :**	Dr. Marc-Antoine Leroy
Date de Rapport :	2024-01-20	**Conclusion B/R :**	Favorable confirmé

1. CADRE DE L'ÉVALUATION ET PROBLÉMATIQUE DE SÉCURITÉ

Ce rapport synthétise l'examen critique des données cumulées de tolérance pour Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate), suite à des remontées de signaux sur le profil hépatique et cardiovasculaire chez les patients polymédiqués.

2. ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DU RAPPORT BÉNÉFICE / RISQUE

L'efficacité clinique démontrée dans les essais de phase III et confirmée par les études observationnelles en vie réelle reste majeure. Les événements indésirables rapportés (Œdèmes des membres inférieurs (8.4%), céphalées (5.1%), myalgies bénignes (3.8%), sensations vertigineuses (3.2%), nausées (2.5%).) sont prévisibles, réversibles et contrôlables par les mesures usuelles de minimisation des risques. Le rapport bénéfice/risque global demeure très nettement positif.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Dr. Marc-Antoine Leroy **Titre :** Directeur Global de la Pharmacovigilance & EU QPPV **Date :** 25/07/2024	**Nom :** Dr. Karim Belkacem **Titre :** Médecin Évaluateur Pharmacovigilance & Gestion des Signaux **Date :** 25/07/2024	**Nom :** Dr. Éléonore Vance **Titre :** Directrice Médicale Globale & VP Affaires Médicales (CMO) **Date :** 25/07/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.